



Voltando para Casa

Um guia para uma recuperação mais segura depois da internação

Nome do paciente: _____

Data: _____

Receber alta é uma boa notícia. Mas **voltar para casa não significa que a recuperação terminou**. Depois de uma internação, a pessoa idosa pode estar mais fraca, caminhar pior, comer menos, usar remédios diferentes e precisar de uma ajuda que não precisava antes. **Os primeiros dias em casa merecem atenção**. Este guia ajuda você a sair do hospital com as respostas certas, conferir os remédios, comparar a pessoa com o que ela era antes, ver se a casa continua segura e acompanhar a recuperação semana a semana. Marque o que já fez.

1. No dia da alta

Não tenha vergonha de perguntar. Antes de sair do hospital, tente entender:

- ☐ Qual foi o principal problema tratado, e se ainda precisa de acompanhamento.
- ☐ Se algum exame está pendente e quem vai buscar o resultado.
- ☐ Quando é a próxima consulta. **O ideal é na primeira ou na segunda semana depois da alta.**
- ☐ Se precisa de especialista, fisioterapia ou outra reabilitação.
- ☐ Se há restrição de atividade e se a alimentação precisa mudar.
- ☐ Se há feridas, curativos, sondas ou outros dispositivos, e quem vai ensinar a cuidar.
- ☐ Quais sinais indicam que é preciso procurar ajuda, e onde procurar.
- ☐ Estou com o **resumo de alta por escrito**, as receitas e os pedidos de exame.

Se algo não ficou claro, peça que expliquem de novo e anote.

Veja também: o guia [Vou para o Hospital. E Agora?](#) tem uma lista de “antes da alta” que complementa esta.

2. Confira os medicamentos

Uma das partes mais importantes da alta é entender como ficou a nova prescrição. Durante a internação, remédios podem ter sido suspensos, trocados, reduzidos, aumentados, iniciados por alguns dias ou acrescentados à rotina.

- | | |
|--|--|
| ☐ Tenho a lista atualizada dos remédios. | ☐ Sei se o anticoagulante ou a insulina mudaram. |
| ☐ Sei quais remédios antigos não devem mais ser usados . | ☐ Sei quais remédios preciso comprar antes de chegar em casa. |
| ☐ Sei quais são novos, e a dose e o horário de cada um. | ☐ Separei os remédios antigos suspensos , fora da gaveta de uso. |
| ☐ Sei se algum é só para alguns dias. | ☐ Organizei os horários (porta-comprimidos ou quadro na parede). |
| ☐ Sei se foi iniciado remédio para dormir, ansiedade ou agitação , e até quando. | |

Evite juntar a receita antiga com a da alta. Na primeira consulta depois da alta, leve todas as caixas, as antigas e as novas.

Veja também: atualize o seu [Meu Retrato de Saúde](#) com a nova lista de remédios.

3. Compare com o que era antes

Faça uma pergunta simples: **a pessoa voltou para casa como era antes?** Use como referência a ficha “Como era antes desta doença” do guia Vou para o Hospital, ou marque aqui o que você lembra.

Antes da internação, a pessoa ☐ caminhava sozinha ☐ usava bengala ou andador ☐ precisava de ajuda ☐ não caminhava

Agora, comparada com antes ☐ igual ☐ um pouco pior ☐ muito pior

Consegue novamente ☐ levantar-se da cama ☐ ir ao banheiro ☐ tomar banho
☐ vestir-se ☐ comer ☐ caminhar dentro de casa

Raciocínio e comportamento ☐ está como antes ☐ mais esquecida ☐ confusa
☐ mais sonolenta ☐ mudança importante de comportamento

O que mudou durante a internação merece ser acompanhado, semana a semana. **O quadro da última página serve para isso.**

Veja também: o [Índice de Katz](#) organiza o que a pessoa consegue fazer sozinha nas atividades básicas e mostra com clareza o que mudou.

4. A casa continua segura?

Uma casa que era segura antes pode deixar de ser quando a capacidade da pessoa muda. Nas primeiras semanas depois da alta, o risco de queda é maior. Olhe de novo para o ambiente:

- | | |
|--|---|
| ☐ O caminho até o banheiro está livre? | ☐ O banheiro está seguro (piso antiderrapante, barra de apoio)? |
| ☐ Há tapetes soltos? | ☐ A pessoa consegue chegar ao banheiro à noite? |
| ☐ A iluminação noturna é adequada? | Se não, há cadeira sanitária ou urinol ao lado da cama , por enquanto? |
| ☐ Existe apoio seguro para levantar da cama e da cadeira? | ☐ Bengala ou andador estão adequados e ao alcance? |
| | ☐ Vai precisar de ajuda no banho e nas transferências, e de equipamento (cadeira de banho, andador)? |

Veja também: o guia [Minha Casa Mais Segura](#) tem o passo a passo por cômodo.

5. Movimento também faz parte da recuperação

Depois de dias no hospital, é comum haver perda de força e de resistência. Quando a equipe liberar:

- ☐ Evite deixar a pessoa o dia inteiro na cama. Sentar para as refeições, fora da cama.
- ☐ Estimule períodos fora do leito, várias vezes ao dia.
- ☐ Retome as caminhadas **aos poucos**: várias saídas curtas valem mais do que uma longa.
- ☐ Use bengala ou andador quando indicados.
- ☐ Siga as orientações de fisioterapia ou reabilitação.

Não espere que a força volte sozinha com o passar dos dias. Ela volta com uso.

Veja também: o [SARC-F](#) é um rastreio rápido de perda de força muscular.

6. Comer e beber merecem atenção

Uma recuperação adequada também depende de nutrição. Observe:

- | | |
|---|---|
| ☐ Está comendo uma quantidade parecida com a habitual? | ☐ Está engasgando? |
| ☐ Está bebendo líquidos ao longo do dia? | ☐ Houve perda importante de peso? (Pese uma vez por semana, na mesma balança.) |
| ☐ Precisa de ajuda para comer? | ☐ A dentadura está disponível e encaixa bem? |
| ☐ Tem náuseas ou vômitos? | |

Se o apetite está pequeno, **prefira refeições menores e mais frequentes, com uma fonte de proteína em cada uma** (ovo, carne, frango, peixe, leite, iogurte, queijo, feijão).

Veja também: a [Mini Avaliação Nutricional \(MAN\)](#) rastreia o risco de desnutrição, e o guia [Estou Comendo Bem?](#) traz orientações práticas.

7. Pele, intestino e urina

Pequenos problemas passam despercebidos quando a preocupação é com a doença principal. Observe:

- | | |
|--|--|
| ☐ A pele nos pontos de apoio (calcanhares, cóccix, quadris). Mancha vermelha que não some é sinal de alerta. | ☐ Uso de fraldas. Foi o hospital que colocou? Ainda é necessária? |
| ☐ Feridas ou curativos. | ☐ Dor. |
| ☐ O intestino. Depois de uma internação, é comum prender. | ☐ Sono. |
| ☐ A urina: se está urinando, e se há ardência ou urina muito escura. | ☐ Inchaço novo ou que piorou (pés, tornozelos, pernas). |

Se algo mudou em relação ao habitual, comunique à equipe responsável.

Veja também: o guia [Minha Pele Protegida](#) (com o [PDF](#) e a avaliação da pele).

8. Atenção à confusão

Algumas pessoas voltam para casa ainda confusas depois de uma doença aguda ou de uma internação, e pode levar dias ou semanas para melhorar. Observe se a pessoa está:

- | | |
|--|---|
| ☐ Mais confusa. | ☐ Agitada. |
| ☐ Desorientada. | ☐ Com o sono invertido (dorme de dia, acorda à noite). |
| ☐ Excessivamente sonolenta. | ☐ Diferente do comportamento habitual. |

O que ajuda em casa: luz do dia e rotina estável, óculos e aparelho auditivo sempre à mão, líquidos ao longo do dia, noites tranquilas e rostos conhecidos. **Uma mudança aguda não deve ser atribuída automaticamente à idade.** Se a confusão piorou de repente, procure avaliação no mesmo dia.

Veja também: [Sinais que Não Esperam](#), para saber quando uma mudança não deve esperar.

9. Quem vai cuidar?

Antes da internação, a pessoa talvez fosse independente. Agora pode precisar de ajuda por um tempo.

Combinem, de preferência antes de chegar em casa:

- | | |
|--|---|
| ☐ Quem fica responsável pelos remédios? | ☐ Quem organiza as consultas e os exames? |
| ☐ Quem ajuda no banho? | ☐ O cuidador sabe quais sinais deve observar? |
| ☐ Quem acompanha a alimentação? | ☐ Existe alguém para substituir o cuidador principal quando for preciso? |
| ☐ Quem ajuda na mobilidade? | |

Cuidar da recuperação também é organizar quem cuida. O cuidador que não descansa adoece.

Veja também: o guia [Cuidar de Quem Cuida](#) e a [Escala de Zarit](#), que mede a sobrecarga do cuidador.

10. Quando procurar ajuda

Procure orientação diante de uma mudança importante em relação ao estado habitual.

Ligue 192 agora

192

- | | |
|---|---|
| ☐ Falta de ar importante ou que surgiu de repente. | ☐ Sinais de AVC: boca torta, fraqueza de um lado, fala enrolada. |
| ☐ Dor ou pressão no peito. | ☐ Sangramento que não para. |
| ☐ Perda de consciência ou convulsão. | ☐ Queda com trauma importante, ou a pessoa não consegue se levantar. |

Procure pronto-socorro hoje

- | | |
|--|---|
| ☐ Confusão ou sonolência nova. | ☐ Piora da falta de ar, ou inchaço novo nas pernas. |
| ☐ Febre ou calafrios. | ☐ Ferida da cirurgia com vermelhidão, secreção ou dor que aumenta. |
| ☐ Vômitos persistentes, ou recusa de líquidos e de alimentos. | ☐ Incapacidade súbita de levantar ou caminhar. |
| ☐ Quase não urina. | ☐ Piora rápida do estado geral. |

Em dúvida, procure atendimento. O WhatsApp do consultório não é canal de emergência.

Veja também: [Sinais que Não Esperam](#), a folha para deixar à vista.

Meu plano de recuperação

Data da alta	_____
Motivo da internação	_____
Médico ou equipe de referência	_____
Telefone do hospital (dúvidas após a alta)	_____
Próximo retorno (1ª ou 2ª semana)	_____
Exames pendentes	_____
Mudanças nos remédios	_____
Cuidados especiais (curativos, dieta; quem faz)	_____
Equipamentos a providenciar	_____
Minha principal meta nas próximas semanas	_____

Estou recuperando aquilo que conseguia fazer antes?

A recuperação não precisa acontecer de uma vez. Mas precisa ser observada. **Uma vez por semana**, compare com o período anterior à doença e marque: **I** = igual a antes · **P** = um pouco pior · **M** = muito pior.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Semana de	____/____	____/____	____/____	____/____
Caminhar	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Levantar da cama ou da cadeira	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Banho e vestir-se	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Comer e beber	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Raciocínio e conversa	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Sono	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M	☐ I ☐ P ☐ M
Peso (kg)	-----	-----	-----	-----

Se, depois de duas semanas, ainda houver itens em **P** ou **M**, ou se qualquer item piorar, **não espere**: leve esta página à consulta e pergunte:

“O que precisamos fazer para recuperar o que foi perdido?”

Caminhar um pouco melhor. Voltar a tomar banho com menos ajuda. Recuperar o apetite. Voltar a conversar como antes. Retomar pequenas atividades. **Essas mudanças também são resultados do tratamento.**

A alta termina a internação. A recuperação continua em casa.

Este material é educativo e **não substitui as orientações individualizadas** da equipe responsável pela internação e pelo acompanhamento depois da alta.